

Skąd się bierze *uzależnienie*

Alkoholizm nie jest brakiem silnej woli ani porażką moralną. To zaburzenie z silnym podłożem biologicznym, psychicznym i społecznym — i właśnie ta wiedza otwiera drogę do skutecznego leczenia.

CZAS: 15 min Psychoedukacja podłoża **ŹRÓDŁO:** Verhulst i wsp. (2015); Felitti i wsp. (1998); WHO (2018)

JAK UŻYWAĆ

Przejdź przez **trzy poziomy podłoża**: biologiczny (sekcja 01), psychiczny (sekcja 02) i społeczno-kulturowy (sekcja 03). W każdym zaznacz, które elementy dotyczą Cię osobiście. Na końcu zapisz **swoją osobistą mapę ryzyka** — co w Twoim życiu zwiększało, a co chroniło przed uzależnieniem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model *biopsychospołeczny* (Engel, 1977) zastąpił dawną dychotomię „choroba moralna vs. choroba mózgu”. Genetyka odpowiada za ~50–60% wariancji ryzyka **AUD** (Verhulst, 2015) — jedna z najwyższych dziedziczności wśród uzależnień. Niekorzystne doświadczenia dzieciństwa (**ACEs**, ang. *Adverse Childhood Experiences*) zwiększają ryzyko 4x (Felitti, 1998). Polska ma jeden z najwyższych wskaźników AUD w Europie (~10–15% mężczyzn) — to nie przypadek, tylko interakcja genów, urazów rozwojowych i kultury picia. Zrozumienie własnego podłoża nie usprawiedliwia picia — **celuje interwencję**.

01 ⓘ Poziom biologiczny — geny i mózg

GENETYKA — 50–60% RYZYKA

Bliznięta jednojajowe vs. dwujajowe: dziedziczność AUD ~**50–60%** (Verhulst, meta-analiza 2015). Jeśli rodzic ma AUD, Twoje ryzyko jest **4x wyższe**. To nie przesądza — to predyspozycja, jak skłonność do nadciśnienia.

WARIANT *ALDH2* — EFEKT OCHRONNY

Osoby z wariantem *ALDH2**2 (głównie azjatyckie) doświadczają „azjatyckiego flushu” — zaczerwienienia twarzy, nudności po niewielkiej ilości alkoholu. To **biologiczne hamowanie** picia — ich ryzyko AUD jest niższe.

UKŁAD NAGRODY

Alkohol aktywuje uwalnianie dopaminy w *jądrze półkuli* (*NAcc*). U osób z genetyczną wrażliwością ta nagroda jest **silniejsza i bardziej zapamiętywana** — uzależnienie wbudowuje się szybciej.

PIĘĆ I METABOLIZM

Kobiety mają mniej enzymu *ADH* w żołądku i więcej tkanki tłuszczowej — **ta sama dawka** alkoholu daje wyższe stężenie we krwi. Stąd kobiety szybciej rozwijają AUD i powikłania (*telescoping effect*).

02 ⓘ Poziom psychiczny — trauma, regulacja, współwystępowanie

ACES — URAZY ROZWOJOWE

≥4 niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie (przemoc, zaniedbanie, alkoholik w domu) = ryzyko AUD **4x wyższe** (Felitti, 1998).

SAMOREGULACJA EMOCJI

Alkohol jako *samolek* na lęk, gniew, smutek, bezsenność, samotność. Krótkie ulgę kupujesz wysokim kosztem długoterminowym.

WSPÓŁWYSTĘPOWANIE

~40% osób z AUD ma też depresję, lęk, PTSD lub ADHD. Częsta sekwencja: *najpierw zaburzenie, potem picie jako samolek*.

03

**Poziom społeczny i kulturowy — środowisko, w którym pijesz****KULTURA PICIA**

Polska należy do krajów z najwyższym spożyciem alkoholu w Europie (~11 l czystego alkoholu/os./rok, GUS 2022). Picie wpisane w wiele rytuałów: praca, świętowanie, żałoba, odpoczynek.

DOSTĘPNOŚĆ

Sklepy całodobowe, niskie ceny względem dochodu, alkohol w stacjach paliw. Im łatwiejszy dostęp, tym wyższe spożycie populacyjne — udokumentowane WHO.

SIEĆ SPOŁECZNA

Picie współpracowników i znajomych jest **jednym z najsilniejszych** predyktorów własnego picia. Zmiana sieci kontaktów = jedno z najtrudniejszych zadań w terapii.

STRES EKONOMICZNY I ZAWODOWY

Bezrobocie, niestabilna praca, wypalenie zawodowe — silne czynniki ryzyka. Picie po pracy „żeby odciąć” wpisuje się w ten mechanizm.

04

**Moja osobista mapa ryzyka**

Nie wszystkie poziomy zadziały u Ciebie z tą samą siłą. Zapisz, co konkretnie w Twoim życiu **zwiększało** ryzyko, a co — często niezauważane — **chroniło**. To nie ćwiczenie historyczne; to mapa do interwencji.

CZYNNIKI RYZYKA

— co w mojej historii zwiększało prawdopodobieństwo picia

CZYNNIKI CHRONIĄCE

— co pomagało mi pić mniej lub przestawać

CO TERAZ MOGĘ WZMOCNIĆ

— najmniejszy realny krok w stronę czynników chroniących

Klucz: Średni czas od pierwszych objawów AUD do podjęcia leczenia w Polsce — 10 lat. Te 10 lat to nie „kupowanie czasu” — to czas, w którym mózg się reorganizuje wokół alkoholu, a powikłania somatyczne narastają. Wczesne rozpoznanie własnego podłoża skraca to okno. *Felitti i wsp. (1998, badanie ACE, N=17 337): osoby z ≥ 4 ACEs miały 7× wyższe ryzyko alkoholizmu — i to ryzyko spadało, gdy w dorosłym życiu pojawiały się relacje wspierające.*